แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุ

กลุ่มยา	ชื่อยา	เหตุผล	การติดตาม/การจัดการ
Antihypertensive drugs	Nifedipine (immediate)	• มีโอกาสเกิดความดันต่ำ • มีผล reflex tachycardia อาจเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด	• ติดตามระดับความดันโลหิต • เลือกใช้ยาที่ออกฤทธิ์นาน เช่น Amlodipine
	Doxazocin	• มีโอกาสเกิด orthostatic hypotension	• ติดตามระดับความดันโลหิต • เลี่ยงการลุกยืนลุกนั่งอย่างรวดเร็ว
Long-acting benzodiazepines	Diazepam Clonazepam	• อาจทำให้บกพร่องของการรับรู้ • เพิ่มโอกาสการหกล้ม	• ลดขนาดลงช้าๆ • ใช้ยาที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้น เช่น Lorazepam
Tertiary tricyclic Antidepressants	Amitriptyline Imipramine Clomipramine	ฤทธิ์ Anticholinergic สูง ได้แก่ ปัสสาวะขัด ท้องผูก ความดันต่ำ การมองเห็นผิดปกติ	• ลดขนาดยา หรือกินก่อนนอน • เลือกใช้เป็นยาในกลุ่ม SSRIs หรือ SNRIs แทน
Barbiturates	Phenobarbital	• มีโอกาสติดยาและหกล้มสูง • Therapeutic index แคบ • CYP inducer มีโอกาสเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาได้ง่าย	• เริ่มยาขนาดต่ำ และปรับเพิ่มขนาดยาทีละน้อยอย่างช้าๆ • เลือกใช้เป็นยากันชักตัวอื่น เช่น Carbamazepine, Lamotrigine
Analgesic drugs	Pethidine	• ทำให้เกิดภาวะซึม สับสน ง่วงซึม • Metabolite ของยาอาจทำให้เกิดอาการชักได้	• ติดตามอาการกดการหายใจ • ใช้ยาบรรเทาอาการปวดตัวอื่น เช่น morphine, fentanyl
Anticholinergic drug	Chlorpheniramine Hydroxyzine Cyproheptadine	ทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ ปัสสาวะขัด ท้องผูก ความดันต่ำ การมองเห็นผิดปกติ	• ระมัดระวังในผู้ที่มีอายุ >75 ปี หรือผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้ • ใช้ยารุ่นที่ใหม่ขึ้น เช่น loratadine
Narrow therapeutic index	Digoxin Phenytoin Valproic acid Theophylline	มีโอกาสเกิดความเป็นพิษได้สูง	ติดตามระดับยาในเลือด อาการทางคลินิกที่แสดงความเป็นพิษของยาอย่างใกล้ชิด
Anticoagulants	Warfarin Dabigatran Apixaban Enoxaparin	การกำจัดยาโดยตับและไตที่ลดลง มีโอกาสภาวะเลือดออกมากขึ้น	Warfarin: ติดตามระดับ INR • อาการทางคลินิกที่บอกถึงภาวะเลือดออก
Calcium channel blockers	Flunarizine	• กดการทำงานระบบประสาทส่วนกลาง • เพิ่มโอกาส parkinsonism, หกล้ม	• ใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่ได้ผล • ระวังความผิดปกติการเคลื่อนไหว • หยุดยาเมื่อไม่มีข้อบ่งใช้

Reference : American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults

คู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital Manual) ปี 2558

จัดทำโดย : นส.ภ.ณัชชา โพธิ์หอมศิริ รหัส 58010710088 , นส.ภ.ณัฐชยา รุ่งเต่า รหัส 58010720014